Balcão Virtual (Audiências e Assessoria do Magistrado): (54) 97100022 Dr. Montaury, 2107 - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Balcão Virtual (CAP Cível): (54) 99679 0955 - Email: frcaxsul3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5015364-95.2024.8.21.0010/RS

AUTOR: LAURA CRISTINA MAFFEI

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

LAURA CRISTINA MAFFEI ajuizou ação cominatória contra a **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,** sustentando que é beneficiária da ré e portadora de esclerose múltipla, do tipo *remitente-recorrente* de rápida evolução. Através de ressonância magnética constatou-se a presença de lesões cerebrais desmielinizantes. Em razão disso, o médico credenciado prescreveu o tratamento com Cladribrina oral (Mavenclad), como melhor solução para o quadro clínico. Fez digressões sobre o alto custo do medicamento e sobre a negativa da ré no fornecimento, sob o argumento de que não possui cobertura conforme o rol de procedimentos obrigatórios da RN 465 da ANS. Defendeu a incidência do CDC e afirmou que o tratamento da sua doença não pode ser limitado pela demandada, invocando a conduta ilícita da operadora em negar o fornecimento da medicação indicada, fato que lhe causou abalo moral passível de reparação. Também invocou os termos da lei 14.454/2022, da RN 465/2021, sendo que a primeira tornou o rol da ANS exemplificativo. Em sede de tutela de urgência, requereu seja a ré compelida a fornecer de forma gratuita o medicamento Cladribrina, conforme prescrição médica. Pediu a procedência da ação para tornar definitiva a liminar, impondo à ré a obrigação de fornecer a medicação indicada, na forma e quantidade prescrita pelo médico credenciado, sem qualquer ônus, bem como para condenar a demandada na reparação pelo abalo moral sofrido, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00. Juntou documentos e requereu a concessão da AJG.

Com o indeferimento da AJG (evento 7, DESPADEC1), a autora recolheu as custas iniciais.

Na decisão do (evento 13, DESPADEC1) foi indeferido o pleito liminar. A autora agravou de instrumento, recurso que foi provido (5136419-92.2024.8.21.7000 - evento 20, DEC LIM TUTELA2).

A ré comprovou que cumpriu com a determinação judicial (evento 39, PET1).

A ré contestou impugnando o valor da causa. No mérito, confirmou que a autora é beneficiária de plano que opera, que a autora solicitou o remédio indicado, não sendo autorizado o fornecimento por ser de uso domiciliar e de caráter eletivo, inexistindo cobertura contratual. A lei 9.656/98, em seu art. 10, dispõe sobre a exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar. A única exceção a essa regra é para os medicamentos antineoplásicos de uso oral, que não é o caso da autora. A RN 465/2021 da ANS também exclui a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Além disso, a RN 487/22 estabeleceu a possibilidade de contratação, por parte dos beneficiários, de pactos acessórios para cobertura de medicação (em geral) de uso domiciliar, que não é o caso da autora. Por fim, referiu não ter praticado qualquer conduta ilícita a ensejar a reparação buscada, pois a negativa respeitou os termos do contrato. Pediu o acolhimento da preliminar ou a improcedência da demanda. Juntou documentos.

A autora manifestou-se sobre a resposta.

Na decisão do (evento 47, DESPADEC1), foi afastada a preliminar.

Instadas, as partes não manifestaram interesse na dilação probatória.

É o relatório. Passo a fundamentar.

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas além daquelas já carreadas aos autos, por isso passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Pretende a autora seja imposta à ré a obrigação de fornecer a medicação denominada Cladribrina oral (Mavenclad), na forma, quantidade e periodicidade prescritas pelo médico assistente. Afirmou ser portadora de esclerose múltipla, tipo remitente-recorrente de rápida evolução e sustentou a obrigatoriedade de o plano fornecer a medicação de que necessita, pedindo a reparação pelo abalo moral que decorreu da negativa da ré no fornecimento do fármaco.

A autora é beneficiária do plano de saúde operado pela ré e demonstrou ser portadora da patologia informada (evento 1, OUT7), recebendo prescrição médica para uso da medicação em discussão, cujo fornecimento foi negado pela ré (evento 1, LAUDO8, evento 1, RECEIT9 e evento 1, OUT12).

O cerne da controvérsia é saber da obrigatoriedade ou não de a operadora de saúde fornecer a medicação receitada à autora para o tratamento da patologia que está acometida e se a negativa causou ou não abalo moral passível de reparação.

Em que pese a decisão proferida pela superior instância, a conclusão é de que não se deve confirmar em sentença aquele provimento jurisdicional. Isso porque o contrato que regula a relação entre as partes (evento 41, CONTR3) faz referência específica aos eventos não cobertos pelo plano (cláusula 10), discorrendo no item XIII sobre o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, como se extrai:

DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS

Cláusula 10ª: Estão expressamente excluídos das coberturas previstas neste contrato os seguintes serviços:

XIII. medicamentos para tratamento domiciliar: são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, urgência e emergência).

Como se pode depreender da bula[1] do **medicamento**, ele é indicado para tratamento de *"esclerose múltipla recorrente altamente ativa em adultos, conforme definido por características clínicas ou de imagem. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central, que pode manifestar diversos sintomas, como alteração visual (visão) e de equilíbrio (coordenação motora), fraqueza muscular (fadiga), distúrbios de linguagem (fala) e memória. O termo recorrente significa que o paciente apresenta crises repetidas desses sintomas".* A administração é de uso oral, sem qualquer indicativo de que a medicação deva ser ministrada em ambiente hospitalar.

A própria lei 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar das exigências e coberturas mínimas que o plano de saúde deve garantir aos seus segurados. E o medicamento de que necessita a autora, obviamente, é de uso domiciliar.

A ré, em defesa, afirmou que autorizaria a cobertura do medicamento domiciliar requerido, nos termos da RN 487/2022,[2] (que dispõe sobre os princípios para a oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde), caso a autora tivesse realizado contratação específica, o que não ocorreu.

Sobre o fornecimento de medicação de uso domiciliar, a atual jurisprudência do egrégio STJ vai no sentido de excluir o seu fornecimento, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (*Home Care*), nenhum desses casos em discussão, e os incluídos no Rol da ANS para esse fim, na forma dos arts. 10, VI, e 12, I, "c", e II, "g", da lei n° 9.656/98, *verbis*:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento* ***domiciliar****, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;* ***(Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)***
>
> *(...)*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;* ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)***
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;* ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)***

O STJ[3] já tem o entendimento pacificado de que *"na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim*".

Portanto, a exclusão de cobertura para medicamentos de utilização em ambiente domiciliar está prevista no art. 10, VI, da lei dos planos de saúde, bem como no art. 17, parágrafo único, VI, da RN 465/2021 da ANS, com a ressalva dos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, que não é o caso que se cogita, de modo que a operadora não tem a obrigação legal ou contratual de fornecer a medicação que a autora necessita para o tratamento domiciliar.

Consequência disso é a improcedência da ação, com a consequente revogação do provimento liminar deferido pela superior instância, que já foi cumprido pela ré.

Por fim, por ter a negativa do plano respeitado as disposições contratuais e por não ser identificada conduta ilícita alguma da demandada, não se pode acolher a pretensão reparatória por danos morais.

Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação movida por LAURA CRISTINA MAFFEI contra UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Como consequência, revogo a tutela de urgência deferida pela superior instância.

Condeno a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo IPCA a contar do ajuizamento e a partir da vigência da lei 14.905/2024, atualização monetária mediante aplicação da taxa SELIC), considerados os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS FREDERICO FINGER, Juiz de Direito**, em 09/12/2024, às 11:34:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10073030465v18** e o código CRC **48b572d8**.

---

1. https://www.merckgroup.com/br-pt/bulario/PC_Mavenclad.pdf ↩
2. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0487_31_03_2022.html ↩
3. AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023 ↩